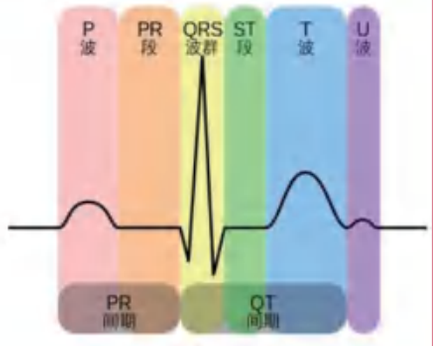


内科含诊断心律失常★★★（1~3题）

- QRS 波
  - P 波后 QRS 波脱落
    - 二度Ⅰ型房室阻滞
      - PR 间期进行性延长、RR 间距进行性缩短（PR 增量减小）
      - 直到一次 QRS 波脱落、受阻 P 波前的 PR 间期延长
      - 包含受阻 P 波在内的 RR 间距＜2 倍正常 PP 间距
      - 最常见房室传导比 3：2 或 5：4，S1 逐渐减弱和心搏脱落（2008）
    - 二度Ⅱ型房室阻滞（2012）
      - PR 间期基本恒定（正常或延长）
      - 部分 P 波后无 QRS 波，S1 基本恒定伴间歇性心搏脱落
    - 三度 / 完全房室阻滞（如强心苷中毒、高钾血症、急性下壁心梗、急性心肌炎）
      - S1 变化不定可呈大炮音“三大炮”（2008）
      - 阻滞在希氏束或以上：一般心室率 40~60、QRS 波形态正常、心律稳定
      - 阻滞在希氏束以下：一般心室率＜40、QRS 波宽大畸形、心律不稳定
- PR 间期
  - ＞0.2s → 房室阻滞（其中一度无 QRS 波脱落）
  - ＜0.12s → 预激综合征（2021）、交界早（P′R 间期）
  - PR 间期不固定→房室分离
    - 室速：心室率明显＞心房率
    - 三度房室阻滞：心房率＞心室率
    - 生理性干扰
- ST 段
  - 压低≥ 0.1mV（心内膜缺血损伤）
    - 心绞痛：暂时
    - 急性非 ST 段抬高型心梗
  - 抬高
    - 变异型心绞痛：暂时
    - 急性 ST 段抬高型心梗
    - 急性心包炎：弓背向下（除 aVR 和 V1 导联外）
    - 急性心梗并发室壁瘤：持续
  - 鱼钩型改变 → 洋地黄效应等
- T 波
  - 倒置 → 冠心病、预激综合征（2021）、某些室性心律失常
  - 高耸 → 急性心梗超急性期、高钾血症
- U 波 → 明显
  - 低钾血症
  - 尖端扭转型室速：QT 间期延长，补镁治疗
- 多无须治疗（2012、2016） → “小场面”（偶发、无症状等）
- 快速型：血压低（休克）我电击
  - R 波存在→同步直流电复律
  - R 波不存在→非同步直流电复律 / 除颤（室扑室颤）
  - 已用强心苷禁止电复律